核准日期：

修改日期：

阿昔洛韦片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

阿昔洛韦可引起急性肾功能衰竭。肾损害患者接受阿昔洛韦治疗时，可造成死亡。应用阿昔洛韦治疗时，需仔细观测有无肾功能衰竭征兆和症状（如少尿、无尿、血尿、腰痛、腹胀、恶心、呕吐等），并监测尿常规和肾功能变化，一旦出现异常应立即停药。应严格按照说明书推荐的适应症和用法用量用药，避免过量应用。应用阿昔洛韦治疗，应摄入充足的水，防止药物沉积于肾小管内。对接受有潜在的肾毒性药物的病人使用阿昔洛韦时应特别注意，因为这可能增加肾功能障碍的危险性，以及增加可逆性的中枢神经系统症状。老年人、孕妇及儿童应慎重使用阿昔洛韦，或在监测下使用。

【药品名称】

通用名称：阿昔洛韦片

英文名称：Aciclovir Tablets

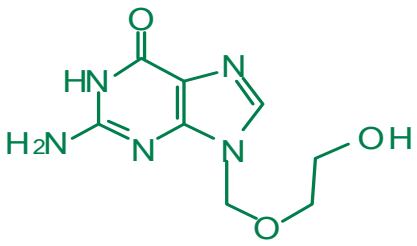
汉语拼音：Axiluowei Pian

【成份】

本品主要成份为阿昔洛韦。

化学名称为 9-（2-羟乙氧甲基）鸟嘌呤。

化学结构式：



分子式：$C_8H_{11}N_5O_3$

分子量：225.21

【性状】本品为白色或类白色片。

【适应症】

本品适用于治疗下列疾病：

1、急性带状疱疹：用于治疗急性带状疱疹。

2、生殖器疱疹：用于治疗初发和复发的生殖器疱疹。

3、水痘：用于治疗水痘。

【规格】

0.1g

【用法用量】

口服，剂量如下：

（一）常用剂量

1、急性带状疱疹：成人每次 0.2g~0.8g，每 4 小时 1 次，1 日 5 次，连用 7～10 天。

2、生殖器疱疹：

初发生殖器疱疹：成人每次 0.2g，每 4 小时 1 次，1 日 5 次，连用 10 天。

复发性生殖器疱疹的慢性抑制治疗：成人每次 0.2g~0.4g，每日 2 次，持续

治疗 4~6 个月或 12 个月，进行再评价。根据再评价结果，选择每次 0.2g、每日 3 次，或每次 0.2g、每日 5 次的治疗方案。未治疗过的生殖器疱疹的发作频率和严重性可能会随时间变化。治疗 1 年后，要对生殖器疱疹感染者的发作频率和严重性进行再评价，以确定是否继续使用本品治疗。

间歇性治疗：如果发现生殖器疱疹复发，建议患者在发现症状或体征的第一时间开始治疗。成人每次 0.2g，每 4 小时 1 次，1 日 5 次，连用 5 天。

3、水痘：

儿童（2 岁及以上）：每次 20mg/kg，每日 4 次，总量为 80mg/kg/日，连用 5 天。40kg 以上的儿童应接受成人治疗水痘剂量。

成人和 40kg 以上的儿童：每次 0.8g，每日 4 次，连用 5 天。

（二）剂量调节

1、急、慢性肾功能损害患者：此类病人的用法用量请参见下表。

肾功能损害患者的剂量调整			
常用剂量	肌酐清除率（ml/min/1.73m^2）	剂量调整方案	
		剂量（g）	给药间隔
每次 0.2g，每 4 小时 1 次	>10 0-10	0.2 0.2	每 4 小时一次，每天 5 次 每 12 小时一次，每日 2 次
每次 0.4g，每 12 小时 1 次	>10 0-10	0.4 0.2	每 12 小时一次，每日 2 次 每 12 小时一次，每日 2 次
每次 0.8g，每 4 小时 1 次	>25 10-25 0-10	0.8 0.8 0.8	每 4 小时一次，每日 5 次 每 8 小时一次，每日 3 次 每 12 小时一次，每日 2 次

2、血液透析：对于需要血液透析的患者，血液透析期间血浆中阿昔洛韦的平均半衰期约为 5 小时。6 小时的血液透析使血药浓度下降 60%，因此，病人

的用药剂量应在每次透析后予以追加调整。

3、腹膜透析：无须在给药期间调整剂量。

【不良反应】

以下不良事件相关的频率划分是估计值。对于大多数事件，没有合适的数据来估计发生率。此外，不良事件的发生率可能会因适应症而不同。

发生频率定义如下：非常常见（≥1/10）、常见（≥1/100 至<1/10）、少见（≥1/1000 至<1/100）、罕见（≥1/10,000 至<1/1000）及非常罕见（<1/10000）。

血液及淋巴系统疾病：

非常罕见：贫血、白细胞减少、血小板减少

免疫系统疾病：

罕见：过敏反应

精神和神经系统疾病：

常见：头痛、头晕

非常罕见：躁动、精神错乱、震颤、共济失调、构音障碍、幻觉、精神病症状、抽搐、嗜睡、脑病、昏迷。

上述事件通常是可逆的，通常在肾功能不全患者或存在其他易感因素的患者中报告（参见【注意事项】）。

呼吸系统、胸廓及纵膈疾病：

罕见：呼吸困难

胃肠道疾病：

常见：恶心、呕吐、腹泻、腹痛

肝胆系统疾病：

罕见：胆红素和肝酶可逆性升高

非常罕见：肝炎、黄疸

皮肤及皮下组织疾病：

常见：瘙痒，皮疹（包括光敏性）

少见：荨麻疹、加速弥漫性脱发。加速弥漫性脱发与多种疾病过程和药物有关，与阿昔洛韦治疗的关系尚不确定。

罕见：血管性水肿

肾脏及泌尿系统疾病：

罕见：血尿素和肌酐升高

非常罕见：急性肾衰竭、肾痛

肾痛可能与肾衰竭和结晶尿有关。

全身疾病和给药部位疾病：

常见：疲劳、发热

【禁忌】

对阿昔洛韦或伐昔洛韦过敏者禁用。

【注意事项】

1、警告：

接受阿昔洛韦治疗的患者有可能出现肾衰竭，在某些情况下可导致死亡（参见【不良反应】）。

免疫功能低下的患者接受阿昔洛韦治疗，曾发生血栓性血小板减少性紫癜/溶血性尿毒症综合征（TTP/HUS），并导致死亡。

2、肾功能损伤的患者服用阿昔洛韦时，建议进行调整剂量。老年患者肾功能可能会下降，同样必须考虑调整剂量的需要。无论是老年患者还是肾功能损伤患者，都有增加神经系统副作用的风险，应密切监测。在报告的病例中，这些反应在停止治疗后通常是可逆的（参见【不良反应】）。正在接受有潜在肾毒性药物的患者，在使用阿昔洛韦时也应谨慎，因为这可能增加肾功能障碍的风险和/或增加可逆性中枢神经系统症状（如在接受静脉注射阿昔洛韦的患者中已报告的症状）的风险。应保持充足的水分。

3、在免疫功能严重受损的患者中，阿昔洛韦长期或反复治疗可能导致病毒株耐药，阿昔洛韦继续治疗可能会无效。

4、目前尚无带状疱疹发作超过 72 小时后才开始治疗的数据。建议患者在确诊带状疱疹后尽可能及早治疗。

5、本品不能治愈生殖器疱疹。没有数据证明本品是否能防止感染传播。生殖器疱疹是一种性传播疾病，因此患者在出现病变和/或症状时，应避免接触患处或性交，以免感染伴侣。生殖器疱疹也可以通过无症状的病毒脱落在没有症状的情况下传播。如果发现生殖器疱疹复发，建议患者在发现症状或体征的第一时间开始治疗。

6、对于健康儿童而言，水痘表现为自限性的轻度到中度疾病，而青少年和成人则比较严重。在对照研究中，治疗在典型水痘疹出现 24 小时内进行，尚无发病后期才开始治疗的有效性资料。目前从临床研究中获得的数据，还不足以确定在免疫功能正常的患者中，使用阿昔洛韦治疗可降低水痘相关并发症的发生率。

7、对驾驶能力和操作机械能力的影响：目前还没有研究阿昔洛韦对驾驶或机械操作能力的影响。但本品可能会导致意识障碍等不良反应，故在汽车驾驶、危险性机械操作等情况下服用本品应谨慎。

8、如果感到有严重或令人烦恼的不良反应、已怀孕或准备怀孕、准备哺乳或有其他问题的患者，应咨询医生，在医生的指导下合理用药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

怀孕：

小鼠、兔和大鼠在器官形成期分别给予阿昔洛韦 450　　mg/kg/天（经口）、50mg/kg/天（皮下注射或静脉注射）和 50　mg/kg/天（皮下注射）均未见致畸作用，其血浆暴露量分别为人的 9～18、16～106 和 11～22 倍。

尚未在妊娠期女性中进行充分和良好的对照研究。从 1984 年至 1994 年 4 月，建立了一项关于孕妇使用阿昔洛韦的前瞻性流行病学记录。在妊娠早期发生阿昔洛韦全身暴露的 749 名孕妇得出了 756 项结果。出生缺陷的发生率与一般人群接近。然而，关于阿昔洛韦对孕妇及胎儿发育的安全性，小规模记录不足以对不太常见的缺陷进行评价，也无法得出可靠的或明确的结论。仅在阿昔洛韦的潜在益处超过对胎儿的潜在危害的前提下，才可考虑在妊娠期间使用阿昔洛韦。

哺乳期妇女：

曾有 2 名妇女在口服阿昔洛韦后在乳汁中检出阿昔洛韦，其浓度为相应血浆浓度的 0.6 至 4.1 倍。这样的浓度可能使哺乳婴儿的阿昔洛韦暴露剂量达到 0.3mg/kg/天。哺乳期应慎用阿昔洛韦，并仅在有用药指征时使用。

【儿童用药】

阿昔洛韦口服制剂在 2 岁以下儿童患者中的安全性和有效性尚未确立。

【老年用药】

在一项带状疱疹治疗临床研究中，376 名年龄≥50 岁、免疫功能正常的受试者接受阿昔洛韦治疗，244 名年龄为 65 岁及以上，111 名为 75 岁及以上。老年受试者和年轻成人受试者之间，没有报告在停止形成新病变时间或愈合时间方面的有效性存在总体差异。65 岁及以上的受试者愈合后疼痛持续时间较长。老年受试者恶心，呕吐和头晕的报告频率更高。老年患者肾功能降低可能性更大，需要减少剂量。老年患者也更有可能出现肾脏或中枢神经系统不良事件。在临床实践中观察到的中枢神经系统不良事件，嗜睡、幻觉、精神错乱和昏迷在老年患者中的报告频率更高（参见【不良反应】）。

【药物相互作用】

药物名称	临床症状 · 措施方法	机制 · 风险因素
丙磺舒	抑制本品的排泄。据报道，本品血浆中的平均半衰期延长18%，平均血浆浓度曲线下面积增加40%。	丙磺舒抑制肾小管分泌OAT1和MATE1，从而抑制药物的肾排泄（参见“药代动力学”）。
西咪替丁	抑制阿昔洛韦的排泄。据报道，平均血浆浓度曲线下面积增加27%（盐酸伐昔洛韦的数据）。	抑制肾小管分泌OAT1、MATE1和MATE2-K。西咪替丁抑制阿昔洛韦的肾排泄（参见“药代动力学”）。
霉酚酸酯	本品与霉酚酸酯代谢物的排泄相互抑制。据报道，两者的平均曲线下面积增加。	本品和霉酚酸酯代谢产物竞争通过肾小管的分泌排出。
茶碱	与本品合用可能引起茶碱的中毒症状。	虽然机制尚不清楚，但可以预测本品抑制茶碱的代谢，从而使茶碱的血药浓度上升。
齐多夫定	与本品合用可引起肾毒性，表现为深度昏睡和疲劳。	
干扰素或甲氨蝶呤（鞘内）	与本品合用可能引起精神异常。	

注：特别是肾功能下降的患者（老年人等）应谨慎给药。

【药物过量】

已有过量服用多达 100 粒胶囊（20g）的报告。与用药过量有关的不良事件报告包括激动、昏迷、癫痫发作和嗜睡。当肾小管内液体溶解度超过 2.5mg/ml 时，阿昔洛韦可能会在肾小管析出。在静脉推注或以不当的高剂量给药以及未对体液和电解质平衡进行适当监测时，有药物过量的报告。这会导致尿素氮和血清肌酐升高，继而出现肾功能衰竭。如果发生急性肾功能衰竭和无尿，患者

则需进行血液透析，直至肾功能恢复（参见【用法用量】）。

【药理毒理】

药理作用

作用机制：阿昔洛韦为合成的核苷类抗病毒药，体内和体外对单纯性疱疹病毒Ⅰ型（HSV-1）、Ⅱ型（HSV-2）及水痘-带状疱疹病毒（VZV）均有抑制作用。

由于阿昔洛韦对由 HSV 和 VZV 编码的胸苷激酶（TK）具有亲和力，使得其具有高选择性的抑制作用。此类病毒酶将阿昔洛韦转化成阿昔洛韦单磷酸盐，即核苷类似物。单磷酸盐进一步被细胞中的鸟苷酸激酶转化成二磷酸盐，再通过细胞中的多种酶转变为三磷酸盐。在体外，阿昔洛韦三磷酸盐中止疱疹病毒 DNA 复制是由以下三种方式完成：1）竞争性地抑制病毒 DNA 聚合酶；2）进入并终止延长的病毒 DNA 链；3）灭活病毒 DNA 聚合酶。阿昔洛韦对 HSV 的抗病毒活性比对 VZV 的抗病毒活性更强，这是因为阿昔洛韦对 HSV　TK 的磷酸化作用更强。

抗病毒活性：疱疹病毒对抗病毒药物的体外敏感性与治疗的临床反应之间的定量关系尚未在人体得到确立，且病毒敏感性测试尚未标准化。敏感性测试结果（以 IC_{50} 表示）可因多种因素发生很大变化。噬斑减少试验中，单纯疱疹病毒分离株的 IC_{50} 范围：HSV-1 为 0.02~13.5 μg/ml、HSV-2 为 0.01~9.9 μg/ml。阿昔洛韦对 VZV 的大多数实验室菌株和临床分离株的 IC_{50} 为 0.12~10.8 μg /ml。阿昔洛韦还显示出对 VZV 的 Oka 疫苗株的活性，平均 IC_{50} 为 1.35 μg/ mL。

耐药性：病毒 TK 和/或 DNA 聚合酶的质变和量变会导致 HSV 和 VZV 对阿昔洛韦产生耐药性。对于免疫功能低下者，尤其是晚期 HIV 感染者，已发现 HSV 和 VZV 临床分离株对阿昔洛韦的敏感性降低。虽然迄今为止这些患者分离得到的大多数阿昔洛韦耐药突变体都是 TK 缺陷突变体，但已分离得到涉及病毒 TK 基因（TK 不全和 TK 改变）和 DNA 聚合酶的其他突变体。对于婴幼儿和免疫功能低下的成人，TK 阴性突变体可能会导致严重的疾病。对于在治疗过程中临床反应不佳的患者，应考虑病毒对阿昔洛韦耐药的可能性。

毒理研究

以下数据描述参考人每天 5 次口服 800 mg（治疗带状疱疹）和每天 5 次口服 200mg（治疗生殖器疱疹）时测得的血浆阿昔洛韦稳态峰浓度，以人高剂量和低剂量给药方案下阿昔洛韦暴露量的倍数表示动物试验中的血药浓度。

遗传毒性：阿昔洛韦进行了 16 项遗传毒性试验，其中 5 项为阳性。

生殖毒性：阿昔洛韦在小鼠（450 mg/kg/天，经口给药）和大鼠（25 mg/kg/天，皮下注射）中未见对生育力和生殖功能有损害。小鼠和大鼠的血药浓度分别为人体的 9～18 倍和 8～15 倍。大鼠和兔给予更高剂量（50 mg/kg/天，皮下注射，血药浓度分别为人的 11～22 倍和 16～31 倍）时，可降低着床率，但不影响产仔数。大鼠在围产期皮下注射阿昔洛韦 50 mg/kg/天，平均黄体数、总着床位点和存活胎仔等均可见有统计学意义的明显下降。

犬连续 1 个月静脉注射阿昔洛韦 50 mg/kg/天（血药浓度为人的 21～41 倍）或连续一年经口给予阿昔洛韦 60 mg/kg/天（血药浓度为人的 6～12 倍）均未见睾丸异常。大鼠和犬在更高剂量下可见睾丸萎缩和精子减少。

小鼠、兔和大鼠在器官形成期分别给予阿昔洛韦 450 mg/kg/天（经口）、50mg/kg/天（皮下注射或静脉注射）和 50 mg/kg/天（皮下注射）均未见致畸作用，其血浆暴露量分别为人的 9～18、16～106 和 11～22 倍。

致癌性：在大鼠和小鼠终生试验中，每日一次管饲给予阿昔洛韦最高剂量达 450 mg/kg，给药组和对照组动物的肿瘤发生率未见统计学差异，亦未见缩短肿瘤发生的潜伏期。小鼠和大鼠的最大血浆浓度分别为人的 3～6 倍和 1～2 倍。

【药代动力学】

吸收

健康成人单次口服阿昔洛韦0.2g和0.8g，给药1.3小时后达到最大血浆浓度，分别为0.63μg/ml和0.94μg/ml，血浆浓度的半衰期约为2.5小时。健康成人连续口服给药，0.2g/4h，1日5次，3日后平均峰浓度为0.77～0.85μg/ml，平均谷浓度为0.41～0.45μg/ml；以相同方式连续口服给药0.8g，平均峰浓度2.02～2.31μg/ml，

平均谷浓度1.18～1.36μg/mL。

代谢、排泄

健康成人单次口服给药阿昔洛韦0.2g和0.8g，48小时内，给药剂量的25.0%和12.0%以原形自尿中排出。口服给药时，尿中代谢产物9-羧甲氧甲基鸟嘌呤约占给药量的7.5%。

分布（国外的数据）

（1）水疱中阿昔洛韦的浓度和阴道分泌物中的转移

阿昔洛韦每天0.2g/4h连续口服给药时，水疱中阿昔洛韦的浓度与血浆中浓度基本相同。连续口服阿昔洛韦10天，0.2g/次,1日5次，药物向阴道分泌物中转移（服药后0.5～1小时：约0.43μg/g）。

（2）乳汁转移

阿昔洛韦0.2g/次，1日5次给药后，乳汁中阿昔洛韦浓度是血浆中浓度的0.6～4.1倍，最高约1.31μg/mL（0.2g服药3小时后）。

肾功能不全患者的药代动力学（国外的数据）

肾功能不全患者静脉输液，阿昔洛韦在体内半衰期延长及全身清除率下降。基于这些结果，建议对肾功能不全的病人应调整剂量（参见“用法用量”）。

重度肾功能障患者，阿昔洛韦2.5mg/kg，静脉输液1小时，血液透析6小时后血浆浓度减少约60%。

儿童用药的药代动力学

单次口服阿昔洛韦0.2g，6岁以上儿童体内的药代动力学与成人相似。骨髓移植的患儿和其他患者的吸收是相同的，肌酐清除率值为40～60ml/min/1.48m^{2}的部分患儿血清中的浓度为2.25μg/mL以上。

【贮藏】密封保存。

【包装】聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片/药品包装用铝箔，24 片/板

×1 板/盒，24 片/板×2 板/盒。

【有效期】12 个月

【执行标准】

【批准文号】国药准字 H10983103

【生产企业】

企业名称：四川科伦药业股份有限公司

生产地址：资阳经济技术开发区安岳工业园（安岳县石桥铺镇）

邮政编码：642350

电话号码：028-86130259

传真号码：028-86139152

网址：http://www.kelun.com